

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient's Copy IVC Filter Placement/Removal

معلومات الإقرار – نسخة المريض زرع/إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي

1. What is an IVC Filter Placement/Removal?

The placement of an Inferior Vena Cava Filter is a procedure that inserts the small metal device (filter) in your Inferior Vena Cava (IVC). The IVC is the main blood vessel in your abdomen that carries blood from your legs back to your heart.

The removal of an Inferior Vena Cava Filter is a procedure that removes the retrievable type filter that is currently implanted in your Inferior Vena Cava (IVC). Your doctors have decided that you no longer need this device and it can be removed.

It is placed / removed by placing a needle and thin plastic tube (catheter) into a vein in your neck or groin.

Iodinated Contrast Media is used to map your veins so the doctor can check the filter and your IVC in the case of removal or placement. If you require more information on Iodinated Contrast Media please request.

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*. Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

This procedure will require the injection of local anaesthetic. Sometimes it may a sedation anaesthetic.

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful. You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

This procedure may only have a light sedation. You need to be able to fully co-operate at times by holding your breath when instructed by the doctor.

Sedation is generally very safe but has a risk with side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- Whether you have any other illness.
- Personal factors, such as whether you smoke or are overweight.

4. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on

1. ما هو وضع/إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي ؟

زرع مصفاة الوريد الأجوف السفلي هو الإجراء الذي يتم خلاله وضع المعدة المعدنية الصغيرة (المصفاة) وزرعها في وريدك الأجوف السفلي . الوريد الأجوف السفلي هو الوعاء الدموي الرئيسي في البطن الذي يعيد الدم من الساقين إلى القلب.

إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي هو الإجراء الذي يتم خلاله إزالة المعدة المعدنية الصغيرة (المصفاة) التي تم زرعها في وريدك الأجوف السفلي . الوريد الأجوف السفلي هو الوعاء الدموي الرئيسي في البطن الذي يعيد الدم من الساقين إلى القلب.

يرى طبيبك أنك لم تعد بحاجة لهذه المعدة وأنه بالإمكان إزالتها. تتم الإزالة بوضع إبرة وأنبوب بلاستيكي رفيع (قسطرة) في أحد أوردة العنق. يتم زرع/إزالة مصفاة الوريد الأجوف السفلي عن طريق إدخال إبرة وأنبوب بلاستيكي رفيع في وريد العنق/ الفخذ.

تستخدم مادة الوسط المتباين المعالجة باليود لرسم خريطة للأوردة ليتمكن الطبيب من التحقق من المصفاة والوريد الأجوف السفلي في حالة زرع/إزالة المصفاة. للمزيد من المعلومات عن مادة الوسط المتباين ، نرجو عدم التردد في طلب ورقة معلومات المريض المتعلقة بمادة الوسط المتباين .

مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى الصابين باعتلال عمل الكلى.

المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
- إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى (اعتلال وظائف الكلى) قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي . قد يتطلب أحياناً إعطائك دواء مسكن.

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟

هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم. قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء.

في هذا الإجراء تعطى مسكن خفيف . من المهم أن تكون أن تكون قادرًا على التجاوب التام مع الطبيب

عندما يطلب منك حبس النفس. الدواء المسكن بشكل عام آمن ، إلا أن له مخاطره وآثاره الجانبية ومضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى .
- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.

4. التحضير للإجراء

سيقوم قسم الأشعة والتصوير الطبي بإعطائك تعليمات متعلقة بالتحضير لهذا

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

how to prepare for your procedure.

You will be told when to have your last meal and drink. This is to make sure your stomach is empty so that if you vomit during the procedure there will be nothing to go into your lungs.

Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.

Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affect of the sedation anaesthetic. If you have a drug habit please tell your doctor. (These activities are forbidden by Shariah Law).

5. During the procedure

A fine needle (IV cannula) will be put into a vein in your arm.

The Radiologist (x-ray doctor) will inject local anaesthetic into the skin. A needle and catheter are inserted into the vein in your neck/groin. Once the catheter is in place the needle is removed.

The catheter is guided through the main blood vessels in your body until it reaches the IVC. You should not be able to feel the catheter inside your body.

X-ray images are taken while the contrast is injected into your IVC.

In the case of removal a special removal catheter or 'snare' is inserted and attached to the implanted filter 'capturing' it. The catheter and filter are removed from the vein.

Once the filter has been removed, firm pressure will be put over the area where the catheter went into your skin (puncture site). This allows the veins to seal over so you will not bleed.

6. After the procedure

The recovery time varies depending on the sedation given. It varies between 2 to 4 hours.

The IV cannula will be removed after you have recovered.

Staff will discuss with you what level of activity is suitable after your procedure.

7. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising could occur. This is usually stopped

الإجراء.

سيتم إبلاغك بأخر موعد يمكنك فيه تناول الطعام والشراب لأنه من المهم أن تكون معدتك فارغة أثناء الفحص ، لتلافي أي تقيؤ قد يؤدي إلى دخول المادة المتقيئة إلى الرئتين.

نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً أو تمارسين الرضاعة الطبيعية.

احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تتناولها دون وصفة والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.

لا تحسني الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير المخدرة (المخالفة للشريعة الإسلامية) التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

5. خلال الإجراء

يتم وضع حقنة رفيعة في أحد أوردة ذراعك (خط وريدي).

يقوم طبيب الأشعة بحقن مخدر موضعي في الجلد . يتم إدخال إبرة وقسطرة في وريد في العنق/الفخذ . تزال الإبرة بعد إدخال القسطرة إلى موقعها المحدد.

تمرر القسطرة داخل الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم حتى تصل الوريد الأجوف السفلي . من المفترض أن لا تشعر بوجود القسطرة في جسمك.

تؤخذ صور بالأشعة السينية بينما يتم حقن مادة الوسط المتباين في الوريد الأجوف السفلي.

يتم إدخال قسطرة إزالة متخصصة تسمى بـ "الكمين - الفخ" بحيث تلامس المصفاة المزروعة و "تلتقطها". تزال بعد ذلك القسطرة والمصفاة.

ما أن تزال المصفاة ، حتى يوضع ضغط قوي على منطقة دخول القسطرة في الجلد (موقع الدخول) . يؤدي ذلك إلى إحكام إغلاق الوريد لمنع حدوث نزيف .

6. بعد انتهاء الإجراء

يتوقف زمن النقاهة بعد الإجراء على الدواء المسكن الذي أعطي لك ، ويتراوح ما بين 2 - 4 ساعات .

يتم إزالة الخط الوريدي بعد نهاية فترة النقاهة من الإجراء.

يناقش معك العاملون مستوى النشاطات المناسب لك القيام بها بعد هذا الإجراء.

7. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يتوقف ذلك عادةً بوضع ضغط و/أو كمادات ثلج في منطقة دخول القسطرة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

by applying pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).

- The IVC Filter may not be able to be insert/removed for technical or medical reasons.
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- A blood clot at the puncture site may form, disrupting the blood flow from the legs, arms or head. This may require treatment with medications.
- Blood clots trapped in the IVC Filter may dislodge during removal and travel to the lungs or block other blood vessels in the body. This may cause a stroke.
- Damage to surrounding structures such as blood vessel, organs and muscles, requiring further treatment.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is possible.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Fall in blood pressure nausea and vomiting
- weakness.
- An existing medical condition getting worse.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment.
- Stroke resulting in brain damage.

8. What are the safety issues when you leave the hospital?

If you were sedated, this will affect your judgment for about 24 hours. For your own safety:

- Do NOT drive any type of car, bike or other vehicle.
- Do NOT operate machinery including cooking implements.
- Do NOT make important decisions or sign a legal document.
- Do NOT drink alcohol, take other mind-altering substances, or smoke. They may react with the anaesthetic drugs

Have an adult with you on the first night after your procedure. Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;

أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).

- قد لا يكون من المستطاع زرع / إزالة المصفاة لأسباب فنية (تقنية) أو لأسباب طبية.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.

- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- قد تتكون خثرة دموية في موضع دخول القسطرة مما يعطل تدفق الدم من الساقين ، الذراعين أو الرأس . قد يتطلب ذلك العلاج بأدوية.
- قد تخرج تخثرات الدم المحتجزة في المصفاة من مكانها أثناء إخراج المصفاة ، وقد تصل إلى الرئتين أو قد تغلق وعاء دموي آخر في الجسم . قد يسبب ذلك السكتة الدماغية.
- ضرر للأنسجة المحيطة كالوعاء الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.

- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة محتملة بسبب هذا الإجراء.

مخاطر إضافية عند استخدام الدواء المسكن:

- إغماء أو دوخة ، خاصة عند بدء الحركة بعد الانتهاء من الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم. غثيان وقيئ.
- ضعف عام.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى.
- مشاكل في القلب والرئتين كالآزمة القلبية أو دخول المادة المتقيئة إلى الرئة مسببة التهاب رئوي مما قد يتطلب تدخل طبي طارئ.
- سكتة دماغية تتسبب في ضرر للمخ.

8. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

إن كنت قد أعطيت دواءً مسكناً ، فقد يؤثر الدواء المسكن لحوالي 24 ساعة على قدرتك في اتخاذ القرار. لضمان سلامتك ولأخذ الأمور القانونية بعين الاعتبار:

- لا تقد أي نوع من المركبات كالسيارة أو الدراجة أو غيرها. يجب أن يرافقك إلى المنزل شخص عاقل بالغ ومسؤول عند خروجك من المستشفى.
- لا تقم بتشغيل أي آلات بما في ذلك أدوات الطهي.
- لا تتخذ أي قرار مهم ولا تقم بتوقيع أي مستند قانوني.

- لا تحتسي الكحول أو تتناول أي من المواد المسببة للهلوسة ، ولا تدخن . كل ذلك قد يتفاعل مع الدواء المسكن.

استعن بشخص بالغ يظل بجوارك في الليلة الأولى بعد الإجراء.

توجه لأقرب قسم الطوارئ أو اتصل بطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Swelling in the limb closest to the puncture site pain unrelieved by simple pain killers.
- Continuous bleeding or swelling at the puncture site.
- Redness or inflammation at the puncture site a fever.
- Other warning signs the doctor may have asked you to be aware of.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

- يرام أو شعرت بالتالي :
- تورم في لطف الجسم الأقرب لموضع دخول القسطرة.
 - ألم لا يختفي بأدوية الألم المعتادة.
 - نزيف مستمر أو تورم مستمر في موضع دخول القسطرة.
 - احمرار أو التهاب في موضع دخول القسطرة .
 - ملاحظة أيأ من الأعراض التي حذرك الطبيب منها وطلب منك التنبيه لها.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
